

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Faculté de Médecine 3 Constantine – SALAH BOUBNIDER
Service d'Hématologie – CHU Constantine

FICHES DE SIMULATION HÉMATOLOGIE – 4e ANNÉE MÉDECINE :

Annonce diagnostic de bêta-thalassémie majeure

Responsable de stage de simulation : Dr Kebaili Sihem

Formateur : Dr Kebaili Sihem

Module : Onco-Hématologie

Niveau : 4e année Médecine

Durée totale : 90 minutes (Prébrief 8 min + Brief 5 min + Scénario 20 min + Débrief 50 min + Feedback ECOS 5 min + Clôture 2 min)

Objectifs pédagogiques

À la fin de la séance, l'étudiant « médecin » doit être capable de :

1. Interpréter un bilan biologique complet (NFS, frottis, réticulocytes, hémolyse, ferritine, électrophorèse Hb)
2. Poser le diagnostic de bêta-thalassémie majeure
3. Structurer l'annonce d'un diagnostic grave (modèle SPIKES)
4. Expliquer le diagnostic et les résultats biologiques en langage simple
5. Aborder la dimension génétique sans culpabiliser les parents
6. Gérer une situation émotionnelle complexe (mère enceinte anxieuse, père accusateur)
7. Proposer une prise en charge structurée (enfant + grossesse en cours)

Contexte clinique

- **Service :** Hématologie pédiatrique
- **Patient :** Enfant de 2 ans, suivi depuis quelques mois pour anémie
- **Consultation du jour :** Annonce des résultats définitifs aux parents
- **Particularité :** Mère enceinte de 12 SA, père accusateur et conflictuel

Matériel nécessaire

- Fiches distribuées à chaque participant
- Salle calme avec table et chaises

- Chronomètre (15 min de simulation)
- Grille d'observation pour les observateurs (facultatif)

FICHE 1 : ÉQUIPE MÉDICALE – RÔLES DES ACTEURS

1. Médecin Leader

Votre mission principale :

- Conduire l'annonce diagnostique selon le modèle SPIKES structuré
- Interpréter le bilan biologique complet et poser le diagnostic de bêta-thalassémie majeure
- Expliquer les résultats en langage simple et accessible aux parents
- Gérer les émotions complexes (mère anxieuse, père accusateur)
- Aborder la dimension génétique sans culpabiliser les parents
- Proposer une prise en charge structurée (enfant + grossesse en cours)
- Organiser le temps de la consultation (respecter les 20 minutes)

Ce qu'on attend de vous :

- Installer un cadre calme et sécurisant dès le début
- Verbaliser le diagnostic de manière progressive (pas brutale)
- Justifier chaque résultat biologique et son lien avec le diagnostic
- Valider les émotions parentales : « C'est normal d'être choqué »
- Désamorcer le conflit conjugal en rappelant la responsabilité génétique partagée
- Communiquer clairement avec empathie (mots simples, vérification de compréhension)
- Conclure par un plan concret : RDV génétique, transfusions, livret, possibilité de revenir

2. Médecin Assistant

Votre mission principale :

- Compléter l'interrogatoire si nécessaire (antécédents familiaux, consanguinité)
- Aider à l'interprétation des résultats biologiques (NFS, frottis, électrophorèse Hb)
- Proposer des diagnostics différentiels si pertinent (autres anémies microcytaires)
- Aider à expliquer la transmission génétique aux parents
- Prendre le relais sur l'explication de la prise en charge si nécessaire

Ce qu'on attend de vous :

- Montrer que vous raisonnez avec plusieurs hypothèses diagnostiques
- Challenger le leader de manière constructive si oubli d'aborder la grossesse en cours
- Participer activement à la gestion des émotions sans monopoliser la parole
- Soutenir le leader face au conflit conjugal

3. Infirmier(ère) / IDE

Votre mission principale :

- Installer les parents confortablement, offrir de l'eau si besoin
- Noter les éléments clés de la consultation (diagnostic annoncé, plan proposé)
- Jouer le rôle de « traduction » : reformuler pour les parents en langage simple si le médecin utilise du jargon
- Rassurer les parents (gestes d'empathie, mouchoirs si pleurs)

Ce qu'on attend de vous :

- Assurer la traçabilité (noter ce qui est dit, moment de l'annonce)
- Anticiper les besoins logistiques (mouchoirs, verre d'eau, contact avec assistante sociale)
- Montrer de l'empathie non verbale (regard, posture, présence rassurante)

4. Scribe

Votre mission principale :

- Noter tout ce que dit l'équipe médicale en temps réel
- Tracer la chronologie : annonce du diagnostic, gestion des émotions, plan proposé
- Servir de support au débriefing (relire les décisions si le formateur le demande)

Ce qu'on attend de vous :

- Précision : noter les mots-clés exacts (« bêta-thalassémie majeure », « électrophorèse HbF 90% », « consultation génétique proposée »)
- Organisation : structurer vos notes (diagnostic annoncé, émotions gérées, plan de PEC)
- Discretion : ne pas interrompre, juste noter

5. Étudiant « Biologie »

Votre mission principale :

- Donner les résultats biologiques lorsque l'équipe les demande (NFS, frottis, réticulocytes, hémolyse, ferritine, électrophorèse Hb)
- Préciser « résultat en attente » si l'examen n'est pas encore disponible
- Ne pas commenter, ne pas donner d'interprétation : uniquement les chiffres et descriptions brèves

Ce qu'on attend de vous :

- Réactivité : donner les résultats dès qu'ils sont demandés
- Neutralité : ne pas orienter le diagnostic par vos commentaires
- Réalisme : si l'équipe demande un examen complémentaire, dire « résultat disponible dans 7-10 jours »

FICHE 2 : PATIENT / FAMILLE

À lire attentivement si vous jouez le rôle du patient ou de la famille

Règles générales pour tous les patients simulés

1. Ne pas inventer de données médicales : répondre uniquement avec les informations du scénario fourni
2. Donner l'information en 2 niveaux :
 - Niveau A (spontané) : informations données dès le début, sans qu'on vous le demande
 - Niveau B (si demandé) : informations données seulement si le médecin pose la bonne question ciblée
3. Jouer l'émotion de manière crédible : inquiétude, peur, colère... mais sans caricature
4. Adapter votre réaction à la qualité de l'explication :
 - Si l'équipe explique bien et rassure → diminuer progressivement l'anxiété
 - Si l'équipe utilise du jargon ou reste floue → montrer l'incompréhension : « Je n'ai pas compris, c'est grave ? »
5. Phrases à placer pendant l'entretien : voir les questions/phrases spécifiques dans votre scénario ci-dessous

Scénario : Annonce diagnostic bêta-thalassémie majeure

Vous êtes (MÈRE) : Madame Samira, 30 ans, mère de l'enfant de 2 ans, enceinte de 12 SA

Informations à donner spontanément (Niveau A)

Dès que le médecin commence à parler :

- « Docteur, qu'est-ce que mon enfant a exactement ? »
- « On nous a dit qu'il a une anémie, mais ça ne passe pas »
- « Il est toujours fatigué, pâle, il ne joue pas comme les autres enfants »

Informations à donner seulement si le médecin pose la question (Niveau B)

- Si on vous demande vos antécédents familiaux : « Dans ma famille, il y a eu des cas d'anémie chronique, mais je ne sais pas exactement quoi »
- Si on vous demande votre grossesse : « Je suis enceinte de 3 mois, c'est une grossesse désirée »
- Si on vous demande la consanguinité : « Oui, mon mari et moi sommes cousins »

Questions/phrases à placer pendant l'entretien

Au bon moment (quand le médecin commence à expliquer ou annonce le diagnostic) :

- « C'est grave docteur ? C'est un cancer ? »

- « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? C'est à cause de moi ? »
- « Et pour ce bébé que je porte ? Il va être malade aussi ? »
- « Est-ce que je dois arrêter cette grossesse ? »
- « Je ne veux pas que mon bébé souffre comme son frère »
- « Il va mourir mon enfant ? »

Émotion et attitude

- Au début : anxieuse, tendue, main sur le ventre (geste de protection)
- Quand « maladie chronique grave » est annoncée : commencer à pleurer
- Si votre mari vous accuse : vous défendre doucement « Ce n'est pas juste ma faute »
- Si le médecin explique bien la génétique (responsabilité partagée) : vous calmer progressivement

Points pièges pour tester l'équipe

- Si le médecin oublie d'aborder la grossesse en cours → insister : « Et pour mon bébé, docteur ? »
- Si le médecin utilise du jargon (« électrophorèse », « HbF ») → dire « Je ne comprends pas ce mot »
- Si le médecin ne rassure pas sur la culpabilité → pleurer plus fort

Vous êtes (PÈRE) : Monsieur Karim, 35 ans, père de l'enfant de 2 ans

Informations à donner spontanément (Niveau A)

Au début, vous êtes plutôt silencieux, bras croisés, air méfiant.

Quand le médecin annonce « maladie génétique héréditaire »

Vous réagissez immédiatement avec colère :

- « Génétique ? Ça veut dire que c'est elle qui lui a donné ça ? »
- « Dans ma famille, il n'y a jamais eu ça, c'est de sa famille que ça vient »
- « Moi je suis en bonne santé, c'est elle le problème »
- (en regardant votre femme) « Tu vois, c'est de ta faute ! »

Escalade du conflit

- « Je ne peux pas accepter ça »
- « Je ne veux pas d'autres enfants malades »
- « Je vais demander le divorce, je ne peux pas vivre comme ça »

Si le médecin recadre et explique la responsabilité partagée

Vous commencez à baisser le ton :

- « Vous êtes sûr ? Moi aussi je suis porteur ? »
- « Mais je n'ai jamais été malade »
- « Alors c'est pas juste sa faute ? »

Quand vous comprenez que c'est partagé

Votre vraie peur ressort :

- « Docteur, est-ce qu'il va mourir ? »
- « Il va souffrir toute sa vie ? »
- « Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui ? »
- « Et pour le bébé, qu'est-ce qu'on fait ? »

À la fin

Si le médecin a bien géré :

- Vous vous calmez, posez des questions rationnelles
- « Comment on va le soigner ? Combien de temps il faut venir à l'hôpital ? »
- Vous pouvez même vous excuser : « Pardon, j'étais énervé »

Émotion principale : Peur profonde sous la colère (mécanisme de défense)

FICHE 3 : OBSERVATEURS

À lire si vous êtes observateur avec grille d'évaluation

Votre rôle pendant le scénario

- Rester silencieux pendant tout le scénario (20 minutes) : ne pas intervenir, ne pas commenter
- Observer et noter sur votre grille : cocher OUI / NON pour chaque critère
- Noter des faits observables, pas des jugements
 - ✓ Bon : « Le leader a annoncé le diagnostic à la 8e minute en disant 'bêta-thalassémie majeure' »
 - ✗ Mauvais : « Le leader était bon »

Grille d'évaluation – Critères à observer

Critère	OUI	NON
1. Diagnostic de bêta-thalassémie majeure formulé clairement	☐	☐
2. Justification biologique (NFS, frottis, électrophorèse Hb)	☐	☐
3. Annonce progressive et structurée (modèle SPIKES)	☐	☐
4. Explication génétique claire (transmission, responsabilité partagée)	☐	☐
5. Gestion émotions mère (validation, réassurance sur culpabilité)	☐	☐
6. Gestion conflit père (recadrage, désamorçage)	☐	☐
7. Abord de la grossesse en cours (risque pour fœtus, DPN)	☐	☐
8. Plan de PEC proposé (transfusions, chélation, suivi)	☐	☐
9. Communication non verbale adaptée (empathie, regard, posture)	☐	☐
10. Organisation et respect du timing (20 min)	☐	☐

Commentaires à rédiger

À la fin du scénario, écrire sur votre grille :

1. 1 point fort principal observé
 - Exemple : « L'équipe a bien expliqué que les deux parents sont porteurs, ce qui a calmé le conflit »
2. 1 point à améliorer en priorité
 - Exemple : « La grossesse en cours n'a jamais été abordée alors que la mère est enceinte de 12 SA »

Votre participation au débriefing

- Le formateur peut vous demander : « Observateurs, à quel moment le diagnostic a-t-il été annoncé ? »
- Répondez factuellement : « À la 12e minute, le leader a dit 'Votre enfant a une bêta-thalassémie majeure' »
- Ne jugez pas : on analyse les actions, pas les personnes

FICHE 4 : ÉTUDIANT-MÉDECIN – DONNÉES CLINIQUES ET BIOLOGIQUES

Cette fiche est à garder pendant le scénario pour consulter les données

Identité du patient

- Nom : Enfant de 2 ans
- Parents : Samira (30 ans, enceinte de 12 SA) et Karim (35 ans)
- Motif : Annonce des résultats définitifs après bilan d'anémie chronique

Antécédents familiaux

- Consanguinité : les parents sont cousins
- Antécédents d'anémie chronique dans la famille maternelle (non documentés)

Contexte clinique

- Enfant suivi depuis plusieurs mois pour anémie chronique
- Symptômes : fatigue persistante, pâleur, retard de croissance

Résultats biologiques

Hémogramme (NFS)

Paramètre	Résultat	Valeurs normales (2 ans)
Hémoglobine (Hb)	6,5 g/dL	10,5-13,5 g/dL
Globules rouges (GR)	3,8 T/L	3,7-5,3 T/L
VGM	62 fL	70-86 fL
CCMH	Abaissée	Normale
Leucocytes	8,5 G/L	Normal
Plaquettes	320 G/L	Normal
Réticulocytes	180 G/L	20-100 G/L

Frottis sanguin :

- Microcytose importante
- Anisopoïkilocytose marquée (formes et tailles variées)
- Nombreuses cellules cibles
- Hypochromie
- Érythroblastes circulants

Bilan d'hémostase

Paramètre	Résultat
Bilirubine libre	Légèrement augmentée
LDH	Augmentées
Haptoglobine	Diminuée

Bilan martial

Paramètre	Résultat
Ferritine	Normale / légèrement augmentée
Coefficient de saturation transferrine	Normal

Électrophorèse de l'hémoglobine

Type d'Hb	Résultat	Valeurs normales
HbA	0% (absente)	> 95%
HbF	90%	< 1%
HbA2	4,5%	2-3%

Interprétation diagnostique attendue

Diagnostic : Bêta-thalassémie majeure (forme homozygote)

Raisonnement :

1. Anémie sévère microcytaire hypochrome (Hb 6,5 g/dL, VGM 62 fL)
2. Non ferriprive (ferritine normale)
3. Hémolyse chronique (bilirubine ↑, LDH ↑, haptoglobine ↓)
4. Frottis évocateur (cellules cibles, érythroblastes)
5. Électrophorèse diagnostique : HbA absente, HbF très élevée, HbA2 augmentée

Points clés à expliquer aux parents (langage simple)

Sur le diagnostic :

- « Votre enfant a une maladie du sang appelée 'thalassémie majeure' »
- « C'est une maladie génétique, c'est-à-dire qu'elle est dans les gènes »
- « C'est une maladie chronique qui va durer toute la vie, mais qu'on peut soigner »

Sur les résultats biologiques :

- NFS : « Le sang de votre enfant est très pauvre en hémoglobine, c'est pour ça qu'il est fatigué et pâle »
- Frottis : « Quand on regarde au microscope, les globules rouges sont petits et anormaux »
- Hémolyse : « Le corps détruit beaucoup de globules rouges »
- Fer : « Ce n'est pas un manque de fer, c'est bien autre chose »
- Électrophorèse : « Cet examen spécial montre que l'hémoglobine normale est absente, ce qui confirme la thalassémie »

Sur la génétique :

- « C'est une maladie héréditaire, transmise par les parents »
- « Vous deux êtes porteurs sains sans le savoir, aucun des deux n'a fait de faute »
- « Quand les deux parents sont porteurs, il y a 25% de risque à chaque grossesse d'avoir un enfant atteint »
- « Pour le bébé que vous attendez, on peut faire un diagnostic prénatal »

Sur la prise en charge :

- « Votre enfant aura besoin de transfusions de sang régulières, toutes les 3-4 semaines »
- « On donnera aussi un médicament pour éviter que le fer s'accumule trop dans le corps »
- « Il y aura un suivi régulier du cœur, du foie, de la croissance »
- « Avec un traitement régulier, votre enfant peut avoir une bonne qualité de vie »

Conseils pour la consultation (modèle SPIKES)

1. **Situation** : Installer un cadre calme, s'asseoir face aux parents
2. **Perception** : Commencer par explorer ce qu'ils savent déjà
3. **Invitation** : Vérifier jusqu'où ils veulent savoir
4. **Knowledge** : Annoncer progressivement, laisser des silences
5. **Emotion** : Valider les émotions (« C'est normal d'être choqué »)
6. **Strategy & Summary** : Résumer et proposer un plan clair

Attention :

- Père accusateur → Désamorcer en rappelant la responsabilité génétique partagée
- Mère très inquiète pour le fœtus → Aborder concrètement le diagnostic prénatal
- Conclure avec un plan : RDV génétique, transfusion programmée, livret d'information, possibilité de revenir

Durée : 20 minutes

FICHE 5 : GRILLE ECOS FINALE – POUR PRÉPARATION À L'EXAMEN

Format ECOS : 5 minutes par station – 5 items évalués

Les 5 items d'évaluation ECOS (communs à tous les cas)

Item	Critères observables	Points
1. Communication	Accueil, écoute active, empathie, ton adapté	/4
2. Diagnostic correct	Bêta-thalassémie majeure identifiée et formulée	/4
3. Prise en charge adaptée	Transfusions, chélation, suivi prescrits et justifiés	/4
4. Explication claire	Mots simples, vérification compréhension	/4
5. Organisation	Structure logique, timing respecté (5 min), conclusion	/4
TOTAL		/20

Items critiques spécifiques au cas « Bêta-thalassémie majeure »

Ces 2 items sont **éliminatoires** : si l'un des deux est absent, la station est invalidée.

Item critique	Validé
1. Reconnaître l'anémie microcytaire non ferriprive avec hémolyse	☐
2. Identifier l'électrophorèse Hb pathologique (HbA absente, HbF élevée)	☐

Conseils pratiques pour l'ECOS (5 minutes)

Structurez votre réponse en 5 blocs de 1 minute :

1. **Diagnostic (30 sec)** : « Il s'agit d'une bêta-thalassémie majeure. »
2. **Justification (1 min)** : « Arguments cliniques : anémie chronique, retard de croissance. Arguments biologiques : VGM 62, HbA absente, HbF 90%, cellules cibles. »
3. **Bilan (1 min)** : « Le bilan est complet : NFS, électrophorèse Hb confirme le diagnostic. Je propose consultation génétique pour la famille et diagnostic prénatal. »
4. **Conduite (1 min)** : « Transfusions régulières toutes les 3-4 semaines, chélation du fer, suivi spécialisé cardiaque et hépatique. »
5. **Explication patient (1 min 30)** : « Votre enfant a une maladie génétique du sang qui nécessite des transfusions régulières. Vous êtes tous les deux porteurs sans le savoir. Pour votre bébé, on peut faire un diagnostic pendant la grossesse. »

Messages clés à retenir pour l'ECOS

Message 1 : Raisonnement structuré

En hématologie, le raisonnement suit toujours :

Clinique → NFS + Frottis + Fer + Électrophorèse Hb → Diagnostic → Conseil génétique → Conduite

Message 2 : Hiérarchisation

On justifie les examens qui changent la décision :

- Électrophorèse Hb = examen diagnostique clé
- Fer normal = élimine carence martiale
- Consultation génétique = obligatoire (enquête familiale + DPN)

Message 3 : Communication

Annoncer un diagnostic grave nécessite :

- Structure SPIKES
- Empathie et validation des émotions
- Langage simple
- Plan concret à la fin

FICHE 6 : FORMATEUR – AIDE-MÉMOIRE RAPIDE

Avant la séance

- ☐ Scénario préparé : bêta-thalassémie majeure, parents (mère enceinte, père accusateur)
- ☐ Objectifs clairs annoncés (2-3 maximum) : diagnostic, annonce structurée, gestion émotionnelle
- ☐ Grilles observateurs imprimées (20 exemplaires)
- ☐ Matériel prêt : résultats biologiques, modèle SPIKES affiché, minuteur
- ☐ Rôles distribués : 5 acteurs (Leader, Assistant, IDE, Scribe, Biologie) + 2 parents simulés + observateurs

Pendant la séance (90 min)

1. Prébrief (8 min) – Script obligatoire

Dire mot pour mot :

« Bonjour. Objectif : vous êtes ici pour apprendre, pas pour être piégés. Confidentialité : ce qui se passe ici reste ici. Contrat de fiction : on fait comme si c'était vrai. Droit à l'erreur : vous pouvez vous tromper, c'est comme ça qu'on apprend. »

2. Brief du cas (5 min)

Donner :

- Contexte : annonce diagnostic bêta-thalassémie majeure
- Parents : mère enceinte de 12 SA, père accusateur
- Tâche : annoncer le diagnostic, gérer les émotions, proposer un plan
- 3 objectifs : diagnostic correct, annonce structurée SPIKES, gestion conflit conjugal
- Matériel disponible : résultats biologiques complets

3. Scénario (20 min)

- Rester en retrait, observer sans intervenir
- Sauf si : blocage total (donner 1 indice neutre) ou conduite dangereuse (culpabilisation excessive d'un parent)
- Noter mentalement 3-4 points clés pour le débriefing

4. Débriefing RAS (50 min) – Structure obligatoire

R = Réaction (5 min) : « Comment vous vous sentez ? »

A = Analyse (35-40 min) : Questions fixes dans l'ordre :

1. Quel était votre diagnostic ?

2. Sur quels éléments biologiques ?
3. Comment avez-vous structuré votre annonce ?
4. Comment avez-vous géré les émotions de la mère ?
5. Comment avez-vous géré le conflit avec le père ?
6. Avez-vous abordé la grossesse en cours et le diagnostic prénatal ?
7. Quel plan de prise en charge avez-vous proposé ?

S = Synthèse (10 min) :

1. Donnez 2 points forts
2. Donnez 1 point à améliorer
3. Plan d'action concret pour le prochain stage

Terminer par 3 messages clés (toujours les mêmes) :

- Message 1 : Raisonnement structuré (clinique → bio → diagnostic → génétique → conduite)
- Message 2 : Annonce structurée (modèle SPIKES pour diagnostics graves)
- Message 3 : Gestion émotionnelle (validation des émotions, désamorçage des conflits, responsabilité génétique partagée)

5. Micro-feedback ECOS (5 min)

Rappeler les 5 items (communication, diagnostic, PEC, explication, organisation) + 2 items critiques du cas.

Conseil pratique : « En ECOS, 5 minutes = diagnostic 30 sec + justification 1 min + bilan 1 min + conduite 1 min + explication patient 1 min 30. »

6. Clôture (2 min)

« Merci. Vous avez le droit d'être fatigués. On se revoit [date]. D'ici là, révisez les messages clés et entraînez-vous entre vous. Annoncer un diagnostic grave est difficile, cette simulation vous prépare à des situations réelles complexes. »

Après la séance

- ☐ Grilles observateurs collectées pour analyse
- ☐ Note mentale : ce qui a bien marché, ce qui est à améliorer pour la prochaine fois

Déroulement de la séance

(Prébrief 8 min + Brief 5 min + Scénario 20 min + Débrief 50 min + Feedback ECOS 5 min + Clôture 2 min)

1. Briefing (10minutes)

- Accueillir tous les participants
- Rappeler les règles : confidentialité, droit à l'erreur, respect mutuel, objectif pédagogique

- Présenter brièvement le cadre clinique
- Distribuer les fiches à chaque participant
- Rappeler la structure SPIKES :
 - Situation : installer le cadre
 - Perception : explorer ce que le patient/famille sait
 - Invitation : vérifier jusqu'où ils veulent savoir
 - Knowledge : annoncer et expliquer
 - Emotion : accueillir les réactions
 - Strategy & Summary : résumer et proposer un plan
- Laisser 2-3 minutes à l'étudiant « médecin » pour lire sa fiche et préparer

2. Simulation (20 minutes)

- Observer sans intervenir
- Noter les points forts et axes d'amélioration
- Arrêter à 15 minutes même si non terminé (gestion du temps fait partie de l'exercice)

3. Débriefing (50 minutes)

Structure en 3 temps :

a) Réaction de l'étudiant « médecin » (5 min)

- « Comment vous êtes-vous senti ? »
- « Qu'est-ce qui a été le plus difficile ? »
- Laisser exprimer les émotions et difficultés

b) Retour des « parents » (5 min)

- Retour de la mère : ce qui l'a aidée, ce qui l'a blessée ou inquiétée
- Retour du père : ce qui a calmé ou augmenté sa colère
- Authenticité des émotions ressenties

c) Analyse pédagogique (10 min)

Points à valoriser :

- Installation du cadre et climat de confiance
- Exploration des connaissances préalables
- Clarté des explications biologiques
- Empathie et gestion des émotions
- Désamorçage du conflit conjugal
- Repositionnement sur la responsabilité génétique partagée

- Proposition de prise en charge concrète

Points à améliorer (exemples) :

- Structure de l'annonce (trop rapide ou trop lent)
- Jargon médical non expliqué
- Gestion des silences et des interruptions
- Oubli d'aborder la grossesse en cours
- Culpabilisation involontaire d'un parent
- Absence de plan concret à la fin

ANNEXE : RAPPEL BÊTA-THALASSÉMIE MAJEURE

Définition

Maladie génétique héréditaire du sang caractérisée par un défaut de production des chaînes bêta de l'hémoglobine, entraînant une anémie chronique sévère.

Transmission

- Mode : Autosomique récessif
- Risque : Si les deux parents sont porteurs sains :
 - 25% d'enfant atteint (thalassémie majeure)
 - 50% de porteur sain
 - 25% non porteur
- Origine : Bassin méditerranéen, Moyen-Orient, Asie, Afrique du Nord

Physiopathologie

- Défaut de synthèse des chaînes β de l'hémoglobine
- Excès de chaînes α $\rightarrow$ précipitation $\rightarrow$ destruction des érythroblastes (érythropoïèse inefficace)
- Hémolyse périphérique des globules rouges anormaux
- Anémie chronique sévère

Diagnostic biologique

Examen	Résultats typiques
NFS	Anémie sévère (Hb < 7 g/dL), microcytose (VGM < 70 fL), hypochromie
Frottis	Cellules cibles, anisopoïkilocytose, érythroblastes circulants
Réticulocytes	Augmentés (érythropoïèse inefficace compensée)
Hémolyse	Bilirubine libre $\uparrow$, LDH $\uparrow$, haptoglobine $\downarrow$
Fer	Ferritine normale ou $\uparrow$ (pas de carence martiale)
Électrophorèse Hb	HbA absente ou très basse, HbF très élevée (70-90%), HbA2 $\uparrow$

Traitement

1. Transfusions régulières : toutes les 3-4 semaines pour maintenir Hb > 9-10 g/dL
2. Chélation du fer : Déféroxamine (Desféral®) ou Déférasirox (Exjade®) pour prévenir la surcharge en fer

3. Surveillance : cardiaque, hépatique, endocrinienne, osseuse
4. Greffe de moelle : seul traitement curatif (si donneur compatible)
5. Thérapies géniques : en développement

Pronostic

- Avec traitement régulier : espérance de vie prolongée (> 50 ans)
- Sans traitement : décès dans l'enfance
- Complications possibles : surcharge en fer (cœur, foie, pancréas), retard de croissance, complications osseuses

Conseil génétique

- Enquête familiale systématique
 - Diagnostic prénatal possible :
 - Prélèvement de villosités choriales (11-13 SA)
 - Amniocentèse (15-18 SA)
 - Analyse génétique du fœtus
 - Accompagnement psychologique du couple
-

Références

[1] Orphanet. (2024). La bêta-thalassémie. <https://www.orpha.net>

[2] Haute Autorité de Santé. (2021). PNDS - Syndromes thalassémiques majeurs et intermédiaires. <https://www.has-sante.fr>

[3] Faculté de Médecine Constantine, Service d'Hématologie CHU Constantine. (2026). Plan standardisé des stages de simulation – Module Hématologie 4e année.